

CHECKLIST KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT

Theo dõi đúng - Ăn uống hợp lý - Vận động đều - Dùng thuốc an toàn

5 VIỆC CẦN NHỚ MỖI NGÀY

- Ăn đúng khẩu phần
- Đo theo kế hoạch
- Nhận biết đường huyết thấp/cao
- Vận động phù hợp
- Dùng thuốc đúng chỉ định

DÀNH CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH CẦN THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT

Có thể in A4, đánh dấu hằng ngày hoặc lưu trên điện thoại

1. Mục tiêu của checklist

Một công cụ nhắc việc, không phải “toa điều trị”

Vì sao cần theo dõi đều?

- Nhìn ra xu hướng tăng hoặc hạ đường huyết thay vì chỉ chú ý một con số đơn lẻ.
- Giúp bác sĩ điều chỉnh kế hoạch ăn uống, vận động và thuốc dựa trên dữ liệu thực tế.
- Phát hiện sớm các dấu hiệu cần xử trí hoặc đi khám.

Mục tiêu đường huyết tham khảo

Chỉ số	Mục tiêu thường dùng	Lưu ý
Trước bữa ăn	80-130 mg/dL	4,4-7,2 mmol/L
1-2 giờ sau bắt đầu ăn	<180 mg/dL	<10,0 mmol/L
HbA1c	<7%	Có thể cần mục tiêu khác

Quan trọng

Mục tiêu phải được cá nhân hóa theo tuổi, thai kỳ, bệnh tim-thận, nguy cơ hạ đường huyết và phác đồ điều trị. Không tự đổi thuốc chỉ vì một lần đo cao hoặc thấp.

Đổi đơn vị nhanh

$\text{mg/dL} \div 18 = \text{mmol/L}$. Ví dụ: 126 mg/dL 7,0 mmol/L.

2. Checklist 5 thói quen hằng ngày

Đánh dấu sau khi hoàn thành

01

ĂN UỐNG CÓ KẾ HOẠCH

- Ăn đúng giờ, không bỏ bữa khi đang dùng thuốc có nguy cơ hạ đường huyết.
- Ưu tiên rau không tinh bột, đậm nạc, ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế nước ngọt và khẩu phần tinh bột quá lớn.

02

VẬN ĐỘNG PHÙ HỢP

- Cố gắng đạt tổng cộng ít nhất 150 phút hoạt động mức vừa mỗi tuần nếu sức khỏe cho phép.
- Đi bộ nhẹ sau bữa ăn có thể hữu ích; dừng lại nếu chóng mặt, đau ngực hoặc khó thở.

03

ĐO VÀ GHI CHÉP

- Đo đúng thời điểm bác sĩ hướng dẫn; rửa và lau khô tay trước đo.
- Ghi cả bữa ăn, vận động, thuốc, triệu chứng để giải thích biến động.

04

DÙNG THUỐC ĐÚNG CHỈ ĐỊNH

- Uống/tiêm đúng liều, đúng giờ. Không tự tăng, giảm hoặc ngưng thuốc.
- Mang danh sách thuốc khi đi khám và báo bác sĩ về sản phẩm bổ sung đang dùng.

05

NGỦ VÀ QUẢN LÝ CĂNG THẲNG

- Duy trì giờ ngủ đều, hướng tới khoảng 7-9 giờ đối với đa số người trưởng thành.
- Căng thẳng, thiếu ngủ hoặc bệnh cấp có thể làm đường huyết khó kiểm soát.

3. Đo đường huyết tại nhà đúng cách

Giảm sai số trước khi diễn giải kết quả

1

Chuẩn bị

Máy đo, que thử còn hạn, kim chích, hộp đựng vật sắc nhọn, sổ hoặc ứng dụng ghi chép.

2

Rửa tay

Rửa bằng xà phòng và nước, lau thật khô. Dư lượng thức ăn hoặc tay ướt có thể làm sai kết quả.

3

Lấy mẫu

Chích cạnh đầu ngón tay, không bóp quá mạnh. Làm theo đúng hướng dẫn của máy và que thử.

4

Ghi đủ bối cảnh

Ghi ngày giờ, trước/sau ăn, món ăn, vận động, thuốc, triệu chứng và tình trạng ốm/sốt.

5

Kiểm tra bất thường

Nếu kết quả không phù hợp với cảm giác cơ thể, rửa tay và đo lại bằng que mới; liên hệ cơ sở y tế khi cần.

Mẹo an toàn

Không dùng chung kim chích. Bỏ kim vào hộp cứng chống đâm xuyên. Bảo quản que thử khô, kín và đúng nhiệt độ theo nhà sản xuất.

4. Khi đường huyết thấp hoặc cao

Biết dấu hiệu và hành động đúng

HẠ ĐƯỜNG HUYẾT: dưới 70 mg/dL (3,9 mmol/L)

Dấu hiệu có thể gồm run tay, vã mồ hôi, đói, hồi hộp, chóng mặt, lú lẫn hoặc buồn ngủ.

Quy tắc 15-15 (khi còn tỉnh và nuốt được):

Dùng khoảng 15 g carbohydrate tác dụng nhanh (ví dụ viên glucose hoặc lượng nước ngọt thường theo nhãn), chờ 15 phút rồi đo lại. Lặp lại nếu vẫn dưới 70 mg/dL. Sau khi ổn, ăn bữa hoặc bữa phụ nếu bữa kế tiếp còn xa.

KHẨN CẤP: bất tỉnh, co giật hoặc không nuốt được

Không cho ăn uống. Dùng glucagon nếu đã được kê và biết cách dùng; gọi 115 hoặc đưa đi cấp cứu.

ĐƯỜNG HUYẾT CAO

Khát nhiều, tiểu nhiều, mệt, nhìn mờ hoặc đau đầu có thể xuất hiện. Uống nước nếu không bị hạn chế dịch; dùng thuốc theo kế hoạch đã được kê; đo lại theo hướng dẫn.

Đi cấp cứu hoặc liên hệ y tế ngay khi:

Khó thở, đau bụng, nôn liên tục, lú lẫn, lơ mơ, hơi thở mùi trái cây, mất nước rõ; hoặc đường huyết rất cao kéo dài và không đáp ứng kế hoạch xử trí của bác sĩ.

Người dùng insulin hoặc có nguy cơ nhiễm toan ceton nên hỏi bác sĩ khi nào cần kiểm tra ceton và ngưỡng nào phải đi cấp cứu.

5. Bảng checklist 7 ngày

In ra và đánh dấu mỗi tối

Nội dung	T2	T3	T4	T5	T6	T7	CN
Ăn đúng kế hoạch	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Vận động phù hợp	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Đo theo chỉ định	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Dùng thuốc đúng giờ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Uống đủ nước*	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ngủ đủ/đều giờ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Kiểm tra bàn chân	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ghi chú bất thường	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

* Lượng nước cần cá nhân hóa nếu có suy tim, suy thận hoặc bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch.

6. Nhật ký đường huyết và bối cảnh

Mang theo khi tái khám

[illegible]

Khi xem lại nhật ký, hãy tìm “mẫu lặp lại”: thường cao sau món nào, thấp sau vận động nào, hoặc thay đổi khi quên thuốc/thiếu ngủ. Không tự điều chỉnh phác đồ; hãy trao đổi với bác sĩ.

7. Checklist tái khám và thông điệp cuối

Chuẩn bị tốt giúp buổi khám hiệu quả hơn

Trước khi đi khám

- ☐ Mang nhật ký đường huyết hoặc dữ liệu từ máy/CGM.
- ☐ Mang danh sách tất cả thuốc, insulin, thực phẩm bổ sung.
- ☐ Ghi lại các lần hạ đường huyết, ngất, té ngã hoặc đường huyết tăng kéo dài.
- ☐ Chuẩn bị câu hỏi về mục tiêu cá nhân, thời điểm đo và cách xử trí khi ốm.
- ☐ Hỏi lịch kiểm tra HbA1c, huyết áp, mỡ máu, mắt, thận và bàn chân.

ĐỪNG CHỈ NHÌN MỘT CON SỐ

Hãy theo dõi xu hướng, bối cảnh và trao đổi với bác sĩ.

Nguồn tham khảo chính

- American Diabetes Association, Standards of Care in Diabetes - 2026 và hướng dẫn tự theo dõi đường huyết.
- CDC: Managing Blood Sugar, Physical Activity, Sleep Health và Hypoglycemia.
- World Health Organization: Diabetes fact sheet và khuyến nghị lối sống.

Lưu ý sử dụng

Tài liệu dành cho giáo dục sức khỏe cộng đồng. Không áp dụng máy móc cho trẻ em, thai kỳ, đái tháo đường type 1, người cao tuổi yếu, suy thận hoặc bệnh cấp mà chưa có hướng dẫn chuyên môn.